ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

Instituto Superior de Engenharia do Porto
Licenciatura em Engenharia Informática

GESTÃO · 2026/27, 1.º SEMESTRE

AstraZeneca PLC

Perfil da organização, estrutura e análise estratégica de uma farmacêutica global.

Nuno Barbosa	1232318
Daniel Cardoso	1232315
Sérgio Neves	1240541
João Carvalho	1232324
José Alves	1230630

Versão: tradução portuguesa **Entrega:** 1.º relatório intercalar **Data:** 17 de outubro de 2026

Índice

1 Introdução **1**
1.1 Tipo de organização . . . 1
1.2 Detentores do capital . . . 1
1.3 Atividades e âmbito . . . 2
1.4 Principais produtos . . . 2
1.5 Principais mercados . . . 3
1.6 Países de presença . . . 3
1.7 Indicadores principais . . . 5
1.8 Contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU . . . 5
1.8.1 O que o Grupo já faz . . . 5
1.8.2 Objetivos adicionais sustentados por evidência do AR . . . 6
1.8.3 O que o Grupo poderia fazer . . . 6

2 Organização **6**
2.1 Organograma . . . 6
2.2 Análise da estrutura . . . 8
2.2.1 Tipo de departamentalização . . . 8
2.2.2 Capacidade de adaptação à mudança . . . 9
2.2.3 Organização formal e informal . . . 10
2.2.4 Flexibilidade ou rigidez . . . 10
2.2.5 Número de níveis hierárquicos . . . 11
2.2.6 Posições de linha e de staff . . . 11
2.3 Propostas de alteração à estrutura . . . 12
2.3.1 Proposta 1 · Coordenação mais forte entre a I&D e a unidade de negócio em cada área terapêutica . . . 12
2.3.2 Proposta 2 · Mais autonomia local no acesso e nos preços . . . 12

3 Planeamento **12**
3.1 Valores, missão e visão . . . 13
3.1.1 Missão . . . 13
3.1.2 Visão . . . 13
3.1.3 Valores . . . 13
3.2 Objetivos nos três níveis de gestão . . . 14
3.3 Análise SWOT e estratégia . . . 14
3.3.1 A envolvente geral: PESTEL . . . 15
3.3.2 O setor: as cinco forças de Porter . . . 17
3.3.3 Dentro da empresa: a cadeia de valor . . . 18
3.3.4 Que recursos dão vantagem: VRIO . . . 22
3.3.5 Juntar tudo: a SWOT . . . 23
3.3.6 O que mais importa . . . 24
3.3.7 Cruzamento dos fatores . . . 25
3.3.8 Estratégia proposta . . . 26

Referências **27**

1 Introdução

A AstraZeneca PLC é uma empresa farmacêutica global, orientada pela ciência, cotada em Londres, Estocolmo e Nova Iorque [1, p. 71], com $58,739m de Receita Total [1, p. 125] e 96,100 empregados em 2025 [1, p. 27]. Esta secção apresenta o que a empresa é, o que faz, onde opera e qual a sua dimensão, e termina com o seu contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Salvo indicação em contrário, os dados provêm do *Annual Report and Form 20-F Information 2025* da AstraZeneca ("o Relatório e Contas", abreviado "AR" no texto) [1]; os números de página são os que estão impressos nas páginas do relatório. A AstraZeneca PLC e as suas subsidiárias são designadas por "o Grupo", os valores estão em dólares norte-americanos, e "$m" e "$bn" significam milhões e milhares de milhões. Os blocos marcados como Análise são interpretação dos autores, não afirmações do Relatório e Contas.

1.1 Tipo de organização

A AstraZeneca PLC é uma *public limited company*, de responsabilidade limitada por ações, constituída e domiciliada em Inglaterra e no País de Gales [1, p. 199]. Foi constituída em 17 de junho de 1992 ao abrigo do Companies Act 1985, e a sua sede social e sede corporativa situam-se em Cambridge, Reino Unido [2, Item 4.A], [1, p. 230]. Em termos portugueses corresponde a uma *sociedade anónima* cotada, uma forma jurídica que o material da unidade curricular cita entre as empresas privadas [3, p. 5].

- **1992–1993.** Empresa constituída em 1992. Em 1993 foram cindidos os negócios farmacêutico, agroquímico e de químicos de especialidade da Imperial Chemical Industries PLC; a empresa chamou-se Zeneca Group PLC até abril de 1999. [2, Item 4.A]
- **1999.** Fusão com a Astra da Suécia; a empresa mudou o nome para AstraZeneca PLC. [2, Item 4.A]
- **2000.** O negócio agroquímico foi cindido e fundido com um negócio semelhante da Novartis para formar a Syngenta AG. [2, Item 4.A]
- **2007.** Aquisição da MedImmune, um negócio de biológicos e vacinas sediado nos Estados Unidos. [2, Item 4.A]
- **2021.** Aquisição da Alexion, um negócio de doenças raras sediado nos Estados Unidos. [2, Item 4.A]

O material da unidade curricular classifica as organizações segundo quem beneficia delas. A AstraZeneca insere-se no tipo de **interesse comercial**, que é habitualmente uma empresa privada cujo benefício principal reverte para os seus proprietários [3, pp. 4–5], e no tipo **privado** quando classificada segundo quem detém o capital [3, p. 6]. É uma empresa **com fins lucrativos**: em 2025 obteve um resultado do período de $10,233m e pagou dividendos de $4,846m [1, p. 125]; para 2025, o Conselho declarou um dividendo anual de $3.20 por ação [1, p. 3], estimado em $4,963m no total [1, p. 225].

As suas ações estão cotadas na London Stock Exchange, na Nasdaq Stockholm e na New York Stock Exchange [1, p. 71]. Desde 2 de fevereiro de 2026 as ações ordinárias estão cotadas diretamente na NYSE, substituindo a anterior cotação nos Estados Unidos de American Depositary Shares na Nasdaq [1, p. 50].

1.2 Detentores do capital

A 31 de dezembro de 2025 o capital social era composto por 1,550,907,927 ações ordinárias de $0.25 cada, mais 50,000 ações preferenciais resgatáveis [1, p. 224]. O AR afirma que os principais acionistas não têm direitos de voto diferentes [1, p. 225] e descreve uma base acionista geograficamente diversificada [1, p. 76]. Quatro grupos detinham 3% ou mais.

Tabela 1.1. Acionistas com 3% ou mais dos direitos de voto. A Wellington Management Company LLP, uma subsidiária, está incluída no valor do Wellington Management Group. Fonte: [1, p. 225].

Acionista	Ações na última comunicação	% na última comunicação	% a 31 dez. 2025
BlackRock	100,885,181	6.96	**6.50**
The Capital Group Companies	77,125,348	4.97	**4.97**
Wellington Management Group LLP	65,120,892	4.96	**4.20**
Investor AB	51,587,810	3.93	**3.33**

A maior participação a 31 de dezembro de 2025 é portanto de 6.50%, e a Empresa não foi notificada de qualquer outra pessoa que detenha uma participação sujeita a comunicação.

1.3 Atividades e âmbito

A AstraZeneca descreve-se como um negócio farmacêutico global, orientado pela ciência e centrado no doente, comprometido com a excelência na investigação, desenvolvimento, fabrico e comercialização de medicamentos sujeitos a receita médica nas áreas de cuidados primários, cuidados especializados e doenças raras [1, p. 8].

A organização comercial está dividida em três regiões: os Estados Unidos, a Europa-Canadá e a Internacional, que inclui a Austrália, a Nova Zelândia e os Mercados Emergentes (entre eles a China). O Japão reporta separadamente [1, p. 32]. Os produtos chegam ao mercado através de empresas locais de marketing detidas na totalidade, de distribuidores e de escritórios de representação locais [1, p. 32].

- **Investigação e desenvolvimento — 16,100:** empregados em I&D nos locais globais do Grupo [1, p. 27]
- **Comercial — 47,400:** empregados na área comercial; a rede tem 10 *hubs* globais [1, p. 27]
- **Fabrico — 16,900:** empregados no fabrico, em 31 locais de operações em 15 países [1, p. 27]
- **Total — 96,100:** empregados (2024: 94,300) [1, p. 27]

1.4 Principais produtos

A receita está organizada em três áreas terapêuticas. A Oncologia é a maior, seguida dos BioFarmacêuticos, que agrupam a área cardiovascular, renal e do metabolismo, a respiratória e a imunologia, e as vacinas e terapias imunitárias [1, pp. 2, 4]. As Doenças Raras surgem em terceiro lugar.

Tabela 1.2. Receita Total por área terapêutica em 2025. As percentagens somam 101% por efeito de arredondamento. Fonte: [1, p. 2].

Área terapêutica	$bn	%
Oncologia	25.6	44
BioFarmacêuticos	23.0	39
Doenças Raras	9.1	16
Outros Medicamentos	1.0	2
Total	**58.7**	**100**

O AR indica as vendas das marcas mais vendidas. Em conjunto, os cinco maiores produtos geraram $30,045m, o que corresponde a 51.1% da Receita Total (calculado a partir de [1, p. 56]: 30,045 ÷ 58,739). O Grupo conta 16 produtos com vendas anuais acima de $1bn [1, p. 50].

Tabela 1.3. Cinco produtos mais vendidos em 2025. Fonte: [1, p. 56].

Produto	$m	
Farxiga	8,492	
Tagrisso	7,254	
Imfinzi	6,063	
Ultomiris	4,718	
Calquence	3,518	

Tabela 1.4. Marcas mais vendidas por área terapêutica. O AR associa a queda do Soliris à transição de doentes para o Ultomiris [1, pp. 24, 56].

Área	Produto	$m	Variação
Oncologia [1, p. 13]	Tagrisso	7,254	+10%
	Imfinzi	6,063	+29%
	Calquence	3,518	+12%
	Lynparza	3,279	−11%
Doenças Raras [1, p. 23]	Ultomiris	4,718	+20%
	Soliris	1,837	−29%
	Strensiq	1,678	+19%
	Koselugo	662	+5%

1.5 Principais mercados

Os Estados Unidos e a Europa representam em conjunto 65% da Receita Total [1, p. 2]. Os Mercados Emergentes são a segunda maior região e a que cresce mais depressa. "Established RoW" abrange o Japão, o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia [1, p. 33].

Tabela 1.5. Receita Total por região em 2025, com o crescimento a taxas de câmbio efetivas. As quotas são de 43%, 26%, 22% e 9% [1, p. 2]; os valores provêm de [1, p. 32] e somam $58,739m.

Região	$m	Crescimento	
Estados Unidos	25,450	+10%	
Mercados Emergentes	15,303	+12%	
Europa	12,739	+5%	
Established RoW	5,247	+5%	

1.6 Países de presença

A AstraZeneca tem presença ativa em mais de 80 países e vende os seus produtos em mais de 125 [1, p. 32]. A sua rede inclui seis centros estratégicos de I&D (Boston, Gaithersburg, Cambridge, Gotemburgo, Xangai e Pequim, este último inaugurado em 2025), dez *hubs* globais e 31 locais de operações em 15 países [1, p. 27].

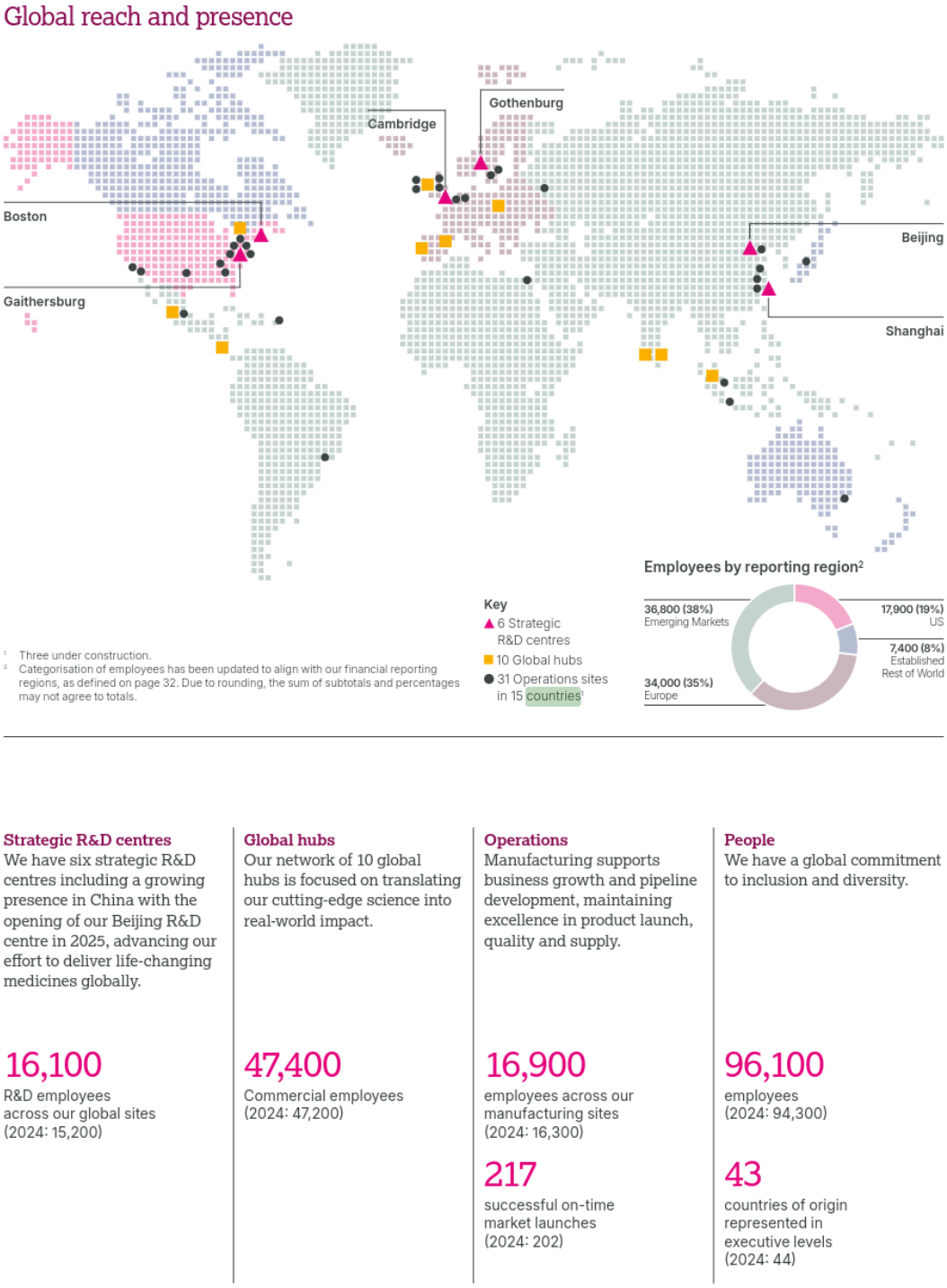


Figura 1.1. Alcance e presença global: centros de I&D, *hubs* globais, locais de operações e empregados por região de reporte. Fonte: [1, p. 27].

Tabela 1.6. Empregados por região de reporte no final de 2025, num total de 96,100. Fonte: [1, p. 27].

Região	Empregados	%
Mercados Emergentes	36,800	38
Europa	34,000	35
Estados Unidos	17,900	19
Established RoW	7,400	8

1.7 Indicadores principais

Tabela 1.7. Indicadores principais de 2025. Fontes: [1, p. 1]; [1, p. 125]; [1, p. 27].

Indicador (2025)	Valor
Receita Total	$58,739m (+9%)
Vendas de Produtos	$55,573m
Receita de Alianças	$3,067m
Receita de Colaborações	$99m
Despesa em I&D	$14,232m
Resultado operacional (reportado)	$13,743m
Resultado do período	$10,233m
Dividendos declarados e pagos	$4,846m
Empregados	96,100

Tabela 1.8. Receita Total de 2023 a 2025, em $bn. Fonte: [1, p. 11].

Ano	$bn	
2023	45.8	
2024	54.1	
2025	58.7	

1.8 Contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

O AR menciona os ODS da ONU uma única vez, quando afirma que as parcerias com organizações multilaterais e ONG os apoiam [1, p. 76]. Não faz o mapeamento das ações para objetivos individuais. O mapeamento que segue é, por isso, Análise dos autores: cada objetivo é ligado às ações e metas que o Grupo reporta.

1.8.1 O que o Grupo já faz

Tabela 1.9. ODS já apoiados pelo Grupo.

ODS	Ação e evidência	Porque contribui
3	**Saúde de qualidade.** 320 milhões de pessoas impactadas positivamente desde 2024, 156 milhões delas de grupos carenciados. Ambição para 2030: mil milhões de pessoas, 400 milhões de comunidades carenciadas. Uma política global de preços escalonados com quatro escalões baseados no rendimento nacional bruto, e Programas de Assistência ao Doente. [1, pp. 5, 41]	O negócio central é descobrir e fornecer medicamentos, e estes programas ampliam o acesso ao tratamento.
13	**Ação climática.** As emissões de âmbito 1 e 2 caíram 88.1% desde 2015, face a uma meta de 98% até 2026. Metas: −50% do âmbito 3 até 2030 e −90% até 2045 (base de 2019), e zero emissões líquidas até 2045. [1, pp. 2, 42]	Define metas de redução mensuráveis, verificadas no âmbito da Science Based Targets initiative [1, p. 42].
6	**Água potável e saneamento.** O sítio do Grupo reporta uma redução de 23% na captação de água face a 2015 [4]. O AR indica uma redução de 24% no consumo de água apenas para a função de Operações [1, p. 33].	Reduz o uso de um recurso partilhado nas suas próprias operações.

ODS	Ação e evidência	Porque contribui
12	**Produção e consumo sustentáveis.** Os resíduos caíram 23% desde 2015, com o objetivo de uma taxa de circularidade de resíduos de 50% até 2030 [4]. O AR também indica −23% de resíduos para as Operações [1, p. 33].	Corta resíduos na origem e define um objetivo de circularidade.
15	**Proteger a vida terrestre.** AZ Forest, um programa de reflorestação e biodiversidade: 66 milhões de árvores plantadas em seis continentes desde 2020 (no final de 2025). O sítio indica uma meta de mais de 100 milhões até 2030 e que a meta foi revista em 2026 [5].	Restaura ecossistemas e biodiversidade.

1.8.2 Objetivos adicionais sustentados por evidência do AR

Tabela 1.10. Outros ODS sustentados por evidência no Relatório e Contas.

ODS	Evidência
5	**Igualdade de género.** As mulheres são 54% da força de trabalho, há sete mulheres no Conselho de Administração (50%), e cinco dos dez membros da Senior Executive Team são mulheres [1, p. 39].
17	**Parcerias para a implementação dos objetivos.** Mais de 1,000 colaborações em todo o mundo [1, p. 37], e parcerias com organizações multilaterais e ONG em apoio dos ODS [1, p. 76].

1.8.3 O que o Grupo poderia fazer

O próprio AR mostra onde estão as maiores lacunas. As três propostas seguintes partem dessas lacunas e não são ações que o Grupo tenha anunciado.

ANÁLISE

- **ODS 13: focar os fornecedores.** Mais de 95% das emissões de gases com efeito de estufa do Grupo estão na cadeia de valor a montante e a jusante, e o Grupo já envolve os fornecedores em metas com base científica [1, p. 42]. Reforçar a descarbonização dos fornecedores atuaria onde está a maior parte das emissões.
- **ODS 3: fechar a lacuna de equidade.** A ambição é alcançar 400 milhões de pessoas de comunidades carenciadas até 2030, e 156 milhões tinham sido alcançadas desde 2024 [1, pp. 5, 41]. Concentrar os programas de acesso nos grupos carenciados aceleraria o progresso rumo a essa meta.
- **ODS 6, 12 e 15: impacto ambiental dos medicamentos.** O AR afirma que os resíduos farmacêuticos que entram no ambiente são atualmente um resultado inevitável do uso de medicamentos pelos doentes, e reporta medidas como avaliações de risco ambiental [1, p. 45]. Estender essas medidas ao longo da cadeia de abastecimento é um próximo passo possível.

2 Organização

2.1 Organograma

O organograma foi desenhado a partir da página de liderança da AstraZeneca [6]. Mostra o Conselho de Administração, o Chief Executive Officer (CEO) e a Senior Executive Team (SET) na Figura 2.1. A fonte de cada caixa é indicada na Tabela 2.1.

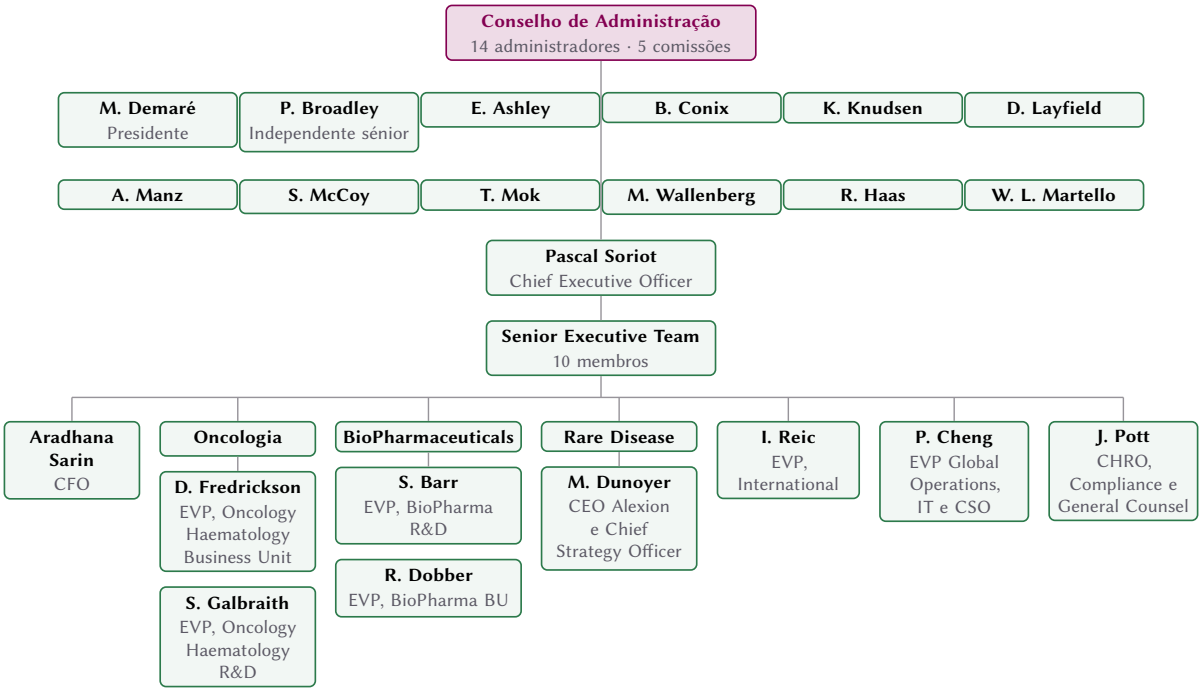


Figura 2.1. Organograma da AstraZeneca, redesenhado para este relatório. Fonte: elaboração dos autores, com base em [6]. Todas as caixas constam do AR [1, pp. 67–70], exceto a alteração no Conselho feita depois da sua publicação [7, 8]; a fonte de cada caixa é indicada na Tabela 2.1.

Tabela 2.1. Fonte de cada caixa da Figura 2.1.

Caixa	Fonte e notas
Conselho de Administração	O Conselho tem 14 administradores e cinco comissões (Auditoria, Remunerações, Nomeações e Governação, Ciência, Sustentabilidade). As matérias não reservadas ao Conselho são delegadas no CEO ou numa das comissões [1, pp. 67–68]. Depois do AR, Nazneen Rahman saiu do Conselho na assembleia geral de 2026 [7] e Wan Ling Martello entrou a 1 de setembro de 2026 [8], pelo que o Conselho continua a ter 14 administradores.
Michel Demaré	Presidente não executivo do Conselho [1, p. 68].
Philip Broadley	Administrador não executivo independente sénior [1, p. 68].
Euan Ashley, Birgit Conix, Karen Knudsen, Diana Layfield, Anna Manz, Sheri McCoy, Tony Mok, Marcus Wallenberg	Constam do AR como administradores não executivos [1, pp. 68–69].
Rene Haas	Administrador não executivo desde 1 de janeiro de 2025 [1, pp. 68–69]. Reeleito na assembleia geral de 2026 com 97,97% dos votos expressos [7].
Wan Ling Martello	Administradora não executiva desde 1 de setembro de 2026, membro da Comissão de Auditoria. Foi nomeada depois da publicação do AR (exercício de 2025), e por isso não consta dele [8].
Pascal Soriot, CEO	Administrador executivo e Chief Executive Officer; membro da SET [1, pp. 68, 70].
Senior Executive Team (SET)	A SET é o órgão através do qual o CEO exerce a autoridade delegada pelo Conselho. Tem 10 membros, cinco deles mulheres [1, pp. 39, 70].
Aradhana Sarin	Administradora executiva e Chief Financial Officer; membro da SET [1, pp. 68, 70].
Oncologia	Uma das três organizações de I&D indicadas no AR [1, p. 26]. Os dois EVP abaixo têm “Oncology Haematology” no seu próprio título no AR [1, p. 70].

Caixa	Fonte e notas
David Fredrickson	Executive Vice President, Oncology Haematology Business Unit [1, p. 70].
Susan Galbraith	Executive Vice President, Oncology Haematology R&D [1, p. 70].
BioPharmaceuticals	Uma das três organizações de I&D indicadas no AR [1, p. 26]. Os dois EVP abaixo têm "BioPharmaceuticals" no seu próprio título no AR [1, p. 70].
Sharon Barr	EVP, BioPharmaceuticals R&D [1, p. 70].
Ruud Dobber	Executive Vice President, BioPharmaceuticals Business Unit, responsável em conjunto por CVRM, R&I e Vacinas & Terapias Imunitárias [1, p. 70].
Rare Disease	Uma das três organizações de I&D indicadas no AR [1, p. 26]. A Alexion, adquirida em 2021, é o negócio de doenças raras da AstraZeneca [2, Item 4.A]; é dirigida dentro da SET por Marc Dunoyer [1, p. 70].
Marc Dunoyer	CEO da Alexion e Chief Strategy Officer da AstraZeneca, membro da SET. Dois cargos oficiais ocupados pela mesma pessoa [1, p. 70].
Iskra Reic	EVP, International: China, mercados asiáticos e euroasiáticos, Médio Oriente e África, América Latina, Austrália e Nova Zelândia. A região Internacional é uma das três regiões comerciais do AR, e a única com um membro da SET próprio; as regiões EUA e Europa-Canadá não têm um responsável separado ao nível da SET no AR [1, pp. 32, 70].
Pam Cheng	EVP, Global Operations, IT e Chief Sustainability Officer [1, p. 70].
Jeff Pott	Chief Human Resources Officer, Chief Compliance Officer e General Counsel (o AR inclui também a propriedade intelectual) [1, p. 70].

À exceção da alteração no Conselho indicada no fim deste parágrafo, cada caixa corresponde a um facto afirmado no AR: a cadeia Conselho → CEO → SET [1, pp. 67, 70]; os dez membros da SET e os respetivos títulos [1, p. 70]; e as três organizações de I&D por área terapêutica indicadas no AR [1, p. 26]. A Oncologia e a BioPharmaceuticals são confirmadas também pelas palavras dos títulos dos seus próprios EVP no AR [1, p. 70]; a Rare Disease é confirmada através da Alexion, que o Form 20-F descreve como o negócio de doenças raras da AstraZeneca [2, Item 4.A] e que Marc Dunoyer dirige como membro da SET [1, p. 70]. O cargo de Iskra Reic, EVP International, corresponde a uma das três regiões comerciais do AR, e é a única com um membro da SET identificado: o AR não dá às regiões EUA e Europa-Canadá um responsável separado ao nível da SET [1, pp. 32, 70]. Nenhuma caixa agrupa membros da SET sem relação entre si sob um título que o AR não usa. O Conselho é apresentado na composição de outubro de 2026: Nazneen Rahman, que consta do AR, saiu na assembleia geral de 2026 [7], e Wan Ling Martello foi nomeada a 1 de setembro de 2026 [8].

2.2 Análise da estrutura

Os critérios abaixo vêm do material da unidade curricular sobre a função organização [9]. Cada afirmação limita-se ao que o AR, o organograma ou o material da unidade curricular sustentam, e cada análise termina com aquilo que não se pode concluir a partir das fontes.

2.2.1 Tipo de departamentalização

Departamentalização significa agrupar atividades em unidades lógicas para executar a estratégia [9, p. 14]. O material da unidade curricular distingue o agrupamento funcional [9, p. 15], o agrupamento divisional por produto, área geográfica, cliente ou projeto [9, pp. 16–19], o agrupamento múltiplo (misto), quando as grandes organizações não podem apoiar-se num único critério [9, p. 20], e as estruturas matriciais, que combinam dois critérios e têm autoridade dual, com os trabalhadores a reportar a dois gestores [9, pp. 21–22].

A AstraZeneca usa vários critérios ao mesmo tempo:

- **Por área terapêutica (produto):** três organizações de I&D — Oncologia, BioPharmaceuticals e Rare Disease [1, p. 26] —, com um EVP distinto para a I&D e para a unidade de negócio na Oncologia e na BioPharmaceuticals [1, p. 70].
- **Por área geográfica:** três regiões comerciais (EUA, Europa-Canadá, Internacional), com o Japão a reportar em separado [1, p. 32]; só a região Internacional tem um membro da SET próprio, Iskra Reic [1, p. 70].
- **Por função:** as Operações (fabrico e abastecimento, IT), a área financeira e os recursos humanos, compliance e jurídico são liderados por membros distintos da SET [1, p. 70]. O próprio site de recrutamento da AstraZeneca indica, de forma independente, as Operações como uma das suas áreas de negócio, abrangendo "the development, manufacturing, testing and delivery of our medicines" [10].

ANÁLISE

A estrutura descreve-se melhor como **departamentalização múltipla (mista)**, combinando os critérios funcional, por área terapêutica e geográfico [9, p. 20].

O QUE AS FONTES NÃO MOSTRAM

Não se pode chamar-lhe matricial. Uma matriz exige autoridade dual [9, pp. 21–22], e nem o organograma nem o AR documentam alguém a reportar a dois gestores: o cargo único de Ruud Dobber, EVP da BioPharmaceuticals Business Unit, cobre em conjunto CVRM, R&I e Vacinas & Terapias Imunitárias [1, p. 70], o que é uma só pessoa a cobrir várias áreas, e não reporte duplo. O AR diz também que o Grupo tem um único segmento reportável e que a descoberta, o desenvolvimento, o fabrico e a comercialização são geridos globalmente numa base altamente integrada [1, p. 147].

2.2.2 Capacidade de adaptação à mudança

O material da unidade curricular liga a função organização à gestão da mudança [9, pp. 4–5], diz que as estruturas com poucos níveis e com delegação respondem mais depressa do que as que têm muitos níveis e centralização [9, p. 7], e que as estruturas funcionais são rígidas e difíceis de reestruturar [9, p. 16].

O AR documenta uma mudança deliberada e prolongada no tempo:

- Depois de adquirir a Alexion em 2021, o Grupo lançou o Post Alexion Acquisition Group Review, um programa global de reestruturação para integrar sistemas, estrutura e processos. Custou $232m em 2025 (de $237m de custos totais de reestruturação) e $3,414m em termos acumulados [1, p. 142], com um custo total previsto de $4.0bn [1, p. 59].
- "Enable an agile organisation" é uma das áreas de foco estratégico, ao lado de "Transform R&D ways of working" [1, p. 11].
- Em dezembro de 2025, o Grupo criou uma unidade dedicada de Enterprise AI para acelerar a Ambition 2030 [1, p. 36].
- Marc Dunoyer lidera a Alexion dentro da SET [1, p. 70]. Antes do cargo atual, a CFO, Aradhana Sarin, foi Chief Financial Officer da Alexion [11], e Sharon Barr foi SVP e Head of Research and Product Development da Alexion [12]; ambos os factos são confirmados pelos anúncios de nomeação da própria AstraZeneca, e não só pelo AR.

ANÁLISE

O Grupo mostrou que consegue absorver uma aquisição de grande dimensão e reorganizar-se de propósito, e aponta a agilidade como objetivo. Isto indica uma **capacidade de adaptação razoável**.

O QUE AS FONTES NÃO MOSTRAM

O AR não dá tempos de decisão, pelo que não é possível avaliar a *rapidez* da resposta. Os percursos de carreira de executivos individuais (por exemplo, Iskra Reic) e uma "reorganização de 2024" não constam do AR, pelo que não são usados.

2.2.3 Organização formal e informal

A organização formal é concebida pela gestão, tem regras e procedimentos e pode ser desenhada num organograma. A organização informal surge da interação social, não está nem pode estar no organograma, e pode acelerar a comunicação ou resistir à mudança [9, pp. 12–13].

Formal: o Conselho reserva para si certas matérias e delega as restantes no CEO ou nas suas cinco comissões [1, p. 67]; a SET é o órgão através do qual o CEO exerce a autoridade delegada [1, p. 70]; existe um Código de Ética e um programa global de compliance [1, p. 34]; e subcomissões transversais e comités de produto alocam recursos [1, p. 147]. O facto de Marc Dunoyer ocupar dois cargos — CEO da Alexion e Diretor de Estratégia — é também *formal*, porque ambos são posições oficiais [1, p. 70].

Ligação documentada mais próxima da organização informal: os Employee Resource Groups, que são grupos voluntários, conduzidos pelos trabalhadores e abertos a todos os trabalhadores [1, p. 39], e o inquérito Pulse aos trabalhadores [1, p. 39].

O QUE AS FONTES NÃO MOSTRAM

Nenhum documento descreve a organização informal real (redes, comunidades de prática, líderes informais). Por definição, o organograma não a mostra [9, p. 12]. O relatório explica, por isso, apenas o conceito e os canais organizados que existem.

2.2.4 Flexibilidade ou rigidez

Segundo o material da unidade curricular, as grandes organizações tendem a ser mais especializadas, mais centralizadas e mais formalizadas [9, p. 11], e a rigidez cresce com a formalização [9, p. 9] e com a centralização [9, p. 7].

- Todas as decisões operacionais significativas são tomadas ao nível da SET, e os recursos são alocados a todo o Grupo por comités de produto [1, p. 147]. Isto indica **centralização** no topo.
- A governação está documentada em detalhe: matérias reservadas, delegações, comissões e respetivos papéis [1, pp. 67, 71].
- A presença comercial está organizada através de empresas de marketing locais detidas na totalidade na maioria dos mercados [1, p. 32], e o Grupo declara um foco numa organização ágil [1, p. 11].

ANÁLISE

A evidência aponta para uma estrutura **formalizada e centralizada na SET**, com especialização por área terapêutica e por região, e com a agilidade como objetivo declarado. Tende para a rigidez na tomada de decisão e para a flexibilidade apenas na intenção declarada.

O QUE AS FONTES NÃO MOSTRAM

O AR não descreve autonomia para as unidades abaixo da SET, nem autonomia regional de preços. A ideia de que a Alexion funciona como uma "empresa autónoma" não é sustentada: o AR diz que o Grupo tem um único segmento reportável e que as áreas funcionais não são geridas em separado [1, p. 147].

2.2.5 Número de níveis hierárquicos

O material da unidade curricular relaciona os níveis com a amplitude de controlo: quanto maior a amplitude, menos níveis e mais achatada a estrutura; amplitudes menores dão mais níveis e uma estrutura alta [9, pp. 8–9]. Nomeia também três níveis de gestão: estratégico, tático e operacional [9, p. 7].

Tabela 2.2. Níveis contados na Figura 2.1, incluindo o Conselho como nível 1.

Ramo	Níveis	Cadeia
CFO, Internacional, Operações Globais e RH/Jurídico	4	Conselho → CEO → SET → membro da SET (3 abaixo do Conselho)
I&D (Oncologia, BioPharmaceuticals, Rare Disease)	5	Conselho → CEO → SET → organização de I&D → EVP (4 abaixo do Conselho), porque o próprio AR indica estas três organizações [1, p. 26]

O QUE AS FONTES NÃO MOSTRAM

A contagem refere-se ao **organograma analisado**, que cobre apenas o topo da empresa. O AR não divulga os níveis abaixo da SET nem as amplitudes de controlo, pelo que não se pode concluir se a estrutura no seu todo é alta ou achatada. Outras contagens de níveis encontradas em fontes secundárias (6 a 9 níveis) não são sustentadas pelo AR e não são usadas.

2.2.6 Posições de linha e de staff

Um gestor de **linha** tem poder de decisão e autoridade sobre os trabalhadores que lhe reportam, dentro da cadeia de comando. Uma unidade ou pessoa de **staff** apoia, aconselha ou assessora os gestores de linha. No exemplo do material da unidade curricular, os diretores de marketing, financeiro e de produção são posições de linha, enquanto o secretariado da direção e a assessoria jurídica são staff [9, p. 8].

Tabela 2.3. Posições de linha e de staff na Senior Executive Team. Classificação: análise dos autores com base em [9, p. 8].

Posição	Responsabilidade segundo o AR	Classificação
EVP da I&D e das unidades de negócio: Fredrickson, Galbraith, Barr, Dobber	Conduzem a I&D e o desempenho comercial das suas áreas terapêuticas [1, p. 70]	**Linha**
Iskra Reic, EVP Internacional	Estratégia e crescimento na região Internacional [1, p. 70]	**Linha**

Posição	Responsabilidade segundo o AR	Classificação
Pam Cheng, EVP Operações Globais, IT e CSO	Operações, IT e sustentabilidade [1, p. 70]	**Mista** — o fabrico é linha; o IT e a sustentabilidade apoiam outras áreas
Jeff Pott, CHRO, Compliance e Diretor Jurídico	Recursos humanos, compliance, jurídico e propriedade intelectual [1, p. 70]	**Staff** — a assessoria jurídica é staff no exemplo da unidade curricular
Aradhana Sarin (CFO); Marc Dunoyer (Alexion, Diretor de Estratégia)	Área financeira; Alexion e estratégia [1, p. 70]	**Não classificada** — o AR não diz quem lhes reporta

2.3 Propostas de alteração à estrutura

Cada proposta abaixo assenta num facto afirmado no AR e nos compromissos descritos no material da unidade curricular.

2.3.1 Proposta 1 · Coordenação mais forte entre a I&D e a unidade de negócio em cada área terapêutica

Base. Na Oncologia e na BioPharmaceuticals, a I&D e a unidade de negócio são lideradas por membros diferentes da SET [1, p. 70]. O AR afirma que já existem subcomissões transversais e comités de produto [1, p. 147].

Proposta. Tornar a coordenação ao nível da área terapêutica permanente e visível, com um fórum conjunto por área onde a I&D e a unidade de negócio partilham prioridades e recursos.

Vantagem. Decisões mais rápidas e menos lacunas entre a investigação e os planos comerciais. **Risco.** Mais reuniões e decisões mais lentas se o fórum não tiver autoridade clara. O material da unidade curricular avisa que, com unidades baseadas no produto, os interesses de cada unidade podem passar à frente dos da organização e as unidades podem competir em vez de cooperar [9, p. 17]; um fórum conjunto serve para contrariar isso.

2.3.2 Proposta 2 · Mais autonomia local no acesso e nos preços

Base. A pressão sobre os preços por parte dos pagadores é uma das principais preocupações comerciais em várias regiões [1, p. 32]. Hoje, o Grupo aplica uma política global de preços por escalões, com quatro escalões baseados no rendimento nacional bruto [1, p. 41], e as decisões operacionais são tomadas ao nível da SET [1, p. 147].

Proposta. Dar às equipas comerciais regionais mais margem para adaptar o acesso e os preços, dentro de limites definidos centralmente pela SET.

Vantagem. A delegação aproxima as decisões do mercado e acelera a resposta [9, p. 7], e, quando as unidades estão muito distantes entre si, é mais adequado atribuir a gestão a um gestor localizado na região [9, p. 17]. **Risco.** Menos consistência entre países; os limites têm de ser claros. O AR não reporta quanta autonomia as regiões têm hoje, pelo que esta proposta necessita dessa informação para ser testada.

3 Planeamento

3.1 Valores, missão e visão

A AstraZeneca não usa os termos "missão" e "visão". Usa um *Purpose* (propósito), que desempenha um papel semelhante ao da missão, ao explicar por que razão a organização existe, a *Ambição 2030*, que corresponde à visão e fixa a direção pretendida, e cinco *Valores*, que orientam a cultura organizacional e a tomada de decisão [1, pp. 8, 10], [13, pp. 15–16].

3.1.1 Missão

"Ultrapassamos as fronteiras da ciência para entregar medicamentos que mudam vidas" [1, p. 8]. A declaração é curta e clara quanto à razão de existir da empresa: criar medicamentos que mudem a vida dos doentes. O Grupo afirma ainda que pretende criar valor para os doentes, a sociedade, o planeta e os acionistas [1, p. 8], o que mostra que reconhece vários stakeholders e não apenas os seus acionistas. O âmbito não faz parte da missão, mas pode ser completado com o modelo de negócio: investigação, desenvolvimento, fabrico e comercialização de medicamentos sujeitos a receita médica em cuidados primários, cuidados especializados e doenças raras [1, p. 8].

3.1.2 Visão

Ser pioneira na ciência, liderar nas suas áreas de doença e transformar os resultados para os doentes, com metas concretas para 2030: pelo menos 20 medicamentos novos e $80bn de Receita Total [1, p. 10]. As metas numéricas tornam a visão mensurável e permitem acompanhar o progresso. Estas metas são usadas como objetivo estratégico na Secção 3.2. A visão global é depois desdobrada em ambições para cada área terapêutica:

- em Oncologia, "eliminar o cancro como causa de morte" [1, p. 14];
- em BioPharmaceuticals, "transformar os cuidados de milhares de milhões de pessoas que vivem com doenças crónicas" [1, p. 16];
- em Doenças Raras, "abrir novas possibilidades", com foco em doenças com necessidade médica significativa não satisfeita, onde o progresso científico foi ausente ou limitado [1, p. 22].

Cada unidade recebe, assim, a sua própria direção, alinhada com a visão do Grupo.

3.1.3 Valores

Tabela 3.1. Os valores da AstraZeneca. Fonte: [1, p. 8].

Valor	Significado
Seguimos a ciência	Ultrapassar as fronteiras da ciência e trabalhar de forma criativa com parceiros
Colocamos os doentes primeiro	Compreender as necessidades dos doentes e tê-las em conta em cada decisão
Jogamos para ganhar	Construir equipas de alto desempenho, inclusivas e diversas, e fazer as escolhas certas para ganhar
Fazemos o que está certo	Aplicar padrões éticos elevados em todos os aspetos do negócio
Somos empreendedores	Agir com urgência, coragem e resiliência, assumindo riscos inteligentes

O foco na ciência e nos doentes está diretamente ligado à investigação e ao desenvolvimento de medicamentos, enquanto a integridade e o espírito empreendedor sustentam uma conduta responsável e a procura de novas oportunidades. Os valores orientam a cultura e as decisões da empresa e são medidos no inquérito interno Pulse: 88% dos colaboradores vêem a empresa como orientada para o doente [1, p. 38]. Medi-los é uma forma de controlo, porque permite à empresa verificar se a cultura corresponde ao que se pretende.

ANÁLISE

A missão, a visão e os valores são coerentes entre si e partilham a mesma ideia central: a ciência ao serviço do doente. O principal desafio para a gestão é conciliar o *jogar para ganhar* com o *colocar os doentes primeiro*, isto é, equilibrar a rentabilidade exigida pelos acionistas com o acesso dos doentes aos medicamentos, num contexto de pressão sobre os preços [1, pp. 32–33].

3.2 Objetivos nos três níveis de gestão

Os objetivos estratégicos fixam os resultados globais de longo prazo, os objetivos táticos traduzem a estratégia em planos departamentais e os objetivos operacionais orientam atividades concretas do dia a dia [13, pp. 5–9]. A AstraZeneca divulga apenas os seus objetivos estratégicos. Os objetivos táticos e operacionais abaixo são aqui propostos, não divulgados pela empresa, desenhados de forma a que cada um contribua para o nível acima. A Ambição 2030 é perseguida através da estratégia *Growth Through Innovation* (crescimento através da inovação), que tem três prioridades: Ciência e Inovação, Crescimento e Liderança em Áreas Terapêuticas, e Pessoas e Sustentabilidade [1, p. 10]. O objetivo tático abaixo insere-se na segunda prioridade e o objetivo operacional apoia a primeira.

Tabela 3.2. Um objetivo para cada nível de gestão. Só o objetivo estratégico é declarado pelo Grupo.

Nível	Objetivo	Horizonte
Estratégico CEO e SET	Lançar pelo menos 20 medicamentos novos e alcançar $80bn de Receita Total até 2030 [1, p. 10]	Longo
Tático Diretor de desenvolvimento clínico em oncologia	Submeter pelo menos três novos medicamentos de oncologia a aprovação regulamentar até ao final de 2027	Médio
Operacional Chefe de equipa de um ensaio clínico	Revisão de pelo menos 98% dos documentos do ensaio dentro do prazo, sem achados críticos, até ao final do próximo trimestre	Curto

Estratégico. Abrange toda a empresa, tem um horizonte longo e exige decisões que só a gestão de topo pode tomar, como o investimento em I&D, que áreas priorizar e as aquisições.

Tático. Transforma a meta estratégica num resultado para uma unidade específica, a Oncologia, que é a maior área (44% da receita) [1, p. 2] e teve 10 resultados positivos de Fase III em 2025 [1, p. 13]. Pertence a um gestor intermédio, que coordena equipas mas não define a estratégia do Grupo.

Operacional. Centra-se numa tarefa concreta, tem um horizonte curto e um indicador preciso. A qualidade da documentação é essencial para a aprovação regulamentar, e o Grupo já reporta zero observações críticas em 42 inspeções externas [1, p. 4].

ANÁLISE

Os três objetivos são SMART e formam uma cascata. Documentação fiável (operacional) permite submissões regulamentares (tático), e as submissões aprovadas tornam-se medicamentos novos e receita (estratégico).

3.3 Análise SWOT e estratégia

A SWOT é construída olhando primeiro para fora da empresa e depois para dentro, seguindo o material da unidade curricular [13, pp. 17–29]. Fora, a PESTEL cobre a envolvente geral [13, pp. 19–21] e as cinco forças de Porter cobrem o setor farmacêutico [13, pp. 21–24]. Dentro, a cadeia de valor mostra

o que a empresa faz [13, p. 25] e a VRIO mostra que recursos lhe dão vantagem [13, p. 26]. As forças e as fraquezas descrevem a empresa hoje; as oportunidades e as ameaças descrevem o que está a chegar [13, p. 27]. Os factos vêm do Relatório e Contas e de outras fontes citadas, enquanto as classificações e os graus atribuídos são uma avaliação, não declarações da empresa.

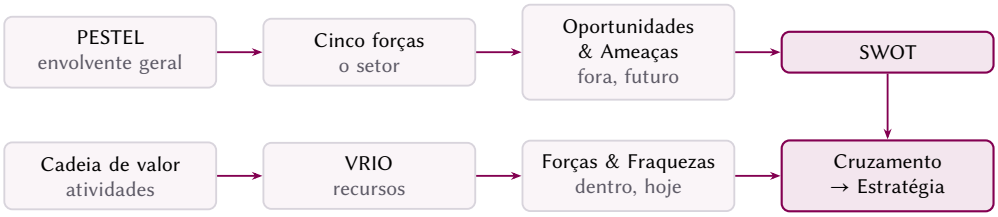


Figura 3.1. Da envolvente à estratégia, seguindo o método do material da unidade curricular [13, pp. 17–29].

3.3.1 A envolvente geral: PESTEL

O cenário fora da AstraZeneca é misto. A procura está do lado da empresa: as pessoas vivem mais tempo, as doenças crónicas e o cancro continuam a crescer, e a despesa em saúde continua a subir. O preço e a regulação trabalham contra ela: os orçamentos de saúde estão apertados, os EUA passaram a negociar preços, e os governos querem limitar a proteção das patentes. O material da unidade curricular pede que se classifique o impacto de cada fator e que se olhe para a forma como os fatores interagem [13, p. 19]; a Tabela 3.3 apresenta isso fator a fator.

Tabela 3.3. Análise PESTEL. A inflação, os níveis de escolaridade e a estabilidade governamental ficam de fora porque o Relatório e Contas não os trata como fatores de negócio.

Fator	Evidência	Classe	Impacto
Político			
Geopolítica	Tensão e rivalidade estratégica entre os EUA e a China, e nacionalismo económico crescente [1, p. 6]. Controlos ao comércio, tarifas e impostos podem aumentar custos ou reduzir receita [1, p. 49].	AMEAÇA	Alto
Localização e tarifas	Os governos incentivam as empresas a localizar operações para reduzir o risco da cadeia de fornecimento [1, p. 7]. O Grupo obteve uma isenção de três anos às tarifas da Secção 232 e planeia investir $50bn em fabrico e I&D nos EUA [1, pp. 4, 32–33].	OPORTUNIDADE	Médio
Fiscalidade	O Grupo pagou $2,845m de imposto sobre o rendimento em 2025. A taxa de imposto Core foi de 18% e está prevista entre 18–22% em 2026 [1, pp. 59, 64].	NEUTRO	Baixo
Económico			
Orçamentos e preços	Os orçamentos da saúde estão sob pressão, o que leva a pressão descendente sobre os preços [1, p. 7]. A consolidação dos pagadores e os reembolsos restritivos geram pressão significativa sobre os preços [1, p. 32].	AMEAÇA	Alto
Crescimento do mercado	Espera-se que a despesa global em saúde cresça 7.1% por ano em 2025–2029, e as vendas farmacêuticas globais cresceram 10.0% em 2025 [1, p. 6]. A previsão de crescimento do PIB global é de 3.3% em 2026 e 3.2% em 2027 [1, p. 7].	OPORTUNIDADE	Alto
Deslocação para mercados emergentes	O poder económico está a passar do G7 para grandes mercados emergentes como a China, a Índia e a Indonésia [1, p. 6].	OPORTUNIDADE	Médio

Fator	Evidência	Classe	Impacto
Taxas de juro e capital	Os empréstimos ao abrigo de linhas contratadas são indexados à SOFR mais uma margem, e a tesouraria gere o risco de taxa de juro, de câmbio e de crédito [1, pp. 61, 64]. O Grupo dispõe de $4,875m de linhas contratadas não utilizadas e sem covenants [1, p. 61].	NEUTRO	Baixo
Câmbios	Alterações significativas nas taxas de câmbio podem afetar negativamente o negócio [1, p. 49]. Às taxas de janeiro de 2026, a Receita Total de 2026 ganharia uma percentagem baixa de um dígito [1, p. 64].	NEUTRO	Baixo
Social			
Envelhecimento	A população com 65 ou mais anos deverá triplicar até 2100, o que aumenta a procura de cuidados [1, pp. 6–7].	OPORTUNIDADE	Alto
Carga de doença	As doenças não transmissíveis representam 75% das mortes não pandémicas. Cerca de 1.4 mil milhões de pessoas têm hipertensão, estimam-se mais de 30 milhões de novos diagnósticos de cancro até 2040, e menos de 10% das doenças raras têm um tratamento aprovado [1, pp. 7, 13, 17, 23].	OPORTUNIDADE	Alto
Talento	O Grupo desenvolve talento internamente: 5,100 promoções e 2,760 contratações externas nos seus centros globais em 2025 [1, p. 39].	NEUTRO	Baixo
Tecnológico			
Inteligência artificial	Estima-se que a IA generativa crie $4–7bn de valor por ano para a indústria farmacêutica, e o AR nota que a IA "vai libertar valor e trazer novos riscos" [1, p. 7].	Oportunidade com risco	Médio
Capacidade de I&D e colaboração	A despesa em I&D foi de $14,232m e estão em curso mais de 100 estudos de Fase III [1, pp. 3, 55]. Mais de 1,000 colaborações dão acesso a tecnologia [1, p. 37].	OPORTUNIDADE	Médio
Ambiental			
Clima	A crise climática agrava as desigualdades em saúde e pressiona os sistemas de saúde [1, p. 7]. O Grupo tem metas próprias com base científica, incluindo zero emissões líquidas até 2045 [1, p. 42]. Os fenómenos climáticos extremos ameaçam instalações, fornecedores e rotas de distribuição [1, p. 44].	AMEAÇA	Médio
Água, resíduos e natureza	As operações reduziram o consumo de água em 24% e os resíduos em 23% face a 2015 [1, p. 33]. O Grupo reconhece os princípios ativos dos seus produtos como o seu impacto mais material na poluição da água [1, p. 45].	AMEAÇA	Baixo
Legal			
Regulação de preços (IRA)	Nos EUA, o Inflation Reduction Act sujeita medicamentos a preços negociados pelo Medicare. A Farxiga foi selecionada e a Calquence entra em vigor em 2027. O AR espera que o impacto na Farxiga seja gerível [1, p. 33]; aqui é classificado como alto, porque a Farxiga é o maior produto, com $8,492m, 14.5% da Receita Total [1, p. 56].	AMEAÇA	Alto
Propriedade intelectual	Governos e pagadores pressionam para limitar a proteção da propriedade intelectual [1, p. 49].	AMEAÇA	Alto

Fator	Evidência	Classe	Impacto
Reforma farmacêutica da UE	O acordo provisório de dezembro de 2025 fixa oito anos de proteção de dados mais um ano de proteção de mercado (prorrogável por um ano se duas de três condições se verificarem), e uma exceção Bolar para que os genéricos possam estar disponíveis no primeiro dia após a expiração da propriedade intelectual [14].	AMEAÇA	Médio
Regulação do setor	Atrasos nas aprovações regulamentares podem atrasar a comercialização e reduzir a receita [1, p. 48]. Os produtos precisam de aprovação de autoridades como a FDA e a EMA [1, p. 20].	AMEAÇA	Médio
Regras de dados e IA	Um conjunto crescente de exigências legislativas e regulamentares abrange os dados e a IA [1, p. 48].	AMEAÇA	Baixo

ANÁLISE

Os fatores não agem isoladamente. As tarifas dos EUA, o acordo de preços e o fabrico local vêm como um pacote único: uma isenção tarifária em troca de preços alinhados com os de outros países ricos e de medicamentos fabricados nos EUA [1, pp. 4, 32–33]. Em 2026 o preço IRA da Farxiga chega no mesmo ano em que esta perde a exclusividade nos EUA, embora o AR espere que o impacto seja gerível [1, p. 33]. O envelhecimento empurra a procura para cima enquanto os orçamentos apertados seguram os preços em baixo, e é por isso que o Grupo usa preços diferenciados por patamares [1, pp. 6–7, 41]. Olhando para a frente, a despesa em saúde continua a crescer até 2029, a Calquence entra em negociação de preço em 2027 e a meta de zero emissões líquidas estende-se até 2045 [1, pp. 6, 33, 42].

3.3.2 O setor: as cinco forças de Porter

Esta secção olha para o mercado dos medicamentos inovadores sujeitos a receita médica. Cada força é classificada como forte, moderada ou fraca [13, p. 21], usando os fatores que o material da unidade curricular enumera para cada uma [13, pp. 22–24].

Tabela 3.4. As cinco forças de Porter. A intensidade não é classificada no Relatório e Contas.

Força	Evidência	Intensidade
Rivalidade	*Número e equilíbrio:* vários grupos grandes de dimensão semelhante. Em 2024 os 10 maiores obtiveram entre $44.47bn (Sanofi) e $64.17bn (Merck & Co.), e a AstraZeneca foi 5.ª com $54.07bn, atrás da Merck & Co., Pfizer, J&J e AbbVie [15]. *Custos fixos:* I&D de $14,232m por ano [1, p. 55] e uma rede de fabrico de 31 instalações [1, p. 33]. *Diferenciação:* produtos protegidos por patentes e posições de liderança até ao fim da exclusividade [1, pp. 9, 56]. *Crescimento:* o setor está a crescer, com a despesa a subir 7.1% por ano até 2029 e as vendas a subir 10.0% em 2025 [1, p. 6], o que alivia a rivalidade. Estão em curso mais de 100 estudos de Fase III [1, p. 3].	FORTE

Força	Evidência	Intensidade
Novos concorrentes	*Capital e tempo:* estima-se que desenvolver um medicamento custe $2.6bn (em dólares de 2013) [16], e a I&D leva 5–15 anos e precisa de aprovação regulamentar [1, p. 9]. *Escala:* vendas em mais de 125 países com 47,400 colaboradores na área comercial [1, p. 32], e mais de 1,000 colaborações [1, p. 37]. *Biotecnológicas:* o Grupo reforça o pipeline através de aquisições, licenciamento e colaborações [1, p. 48], por exemplo a EsoBiotec [1, p. 37]. *Condição:* o AR avisa que limites à proteção da propriedade intelectual levariam a "concorrência acelerada e intensificada" [1, p. 49]. *Barreiras à saída:* o Grupo opera instalações de fabrico especializadas, e o AR regista o fecho de uma fábrica de comprimidos (Bangalore, maio de 2025) [1, p. 33].	FRACA condicional à PI
Fornecedores	*Concentração:* a maior parte do fabrico de API é externa, complementada por capacidade interna crescente [1, p. 33]. A Índia representa 48% dos Drug Master Files de API ativos submetidos à FDA dos EUA e a China 18% em 2024; os ficheiros refletem a localização do fabricante, não o volume [17]. *Substitutos:* alguns inputs não têm alternativa fácil, como os reagentes de sangue de caranguejo-ferradura até à adoção de uma alternativa sintética em 2025 [1, p. 45]. *Mitigação:* dupla fonte de fornecimento, múltiplos fornecedores e monitorização de stocks [1, p. 48].	MODERADA
Clientes	*Concentração:* os pagadores são sobretudo seguradoras e orçamentos nacionais. A consolidação dos pagadores e os reembolsos restritivos geram pressão significativa sobre os preços, e aplicam-se descontos [1, p. 32]. Nos EUA, três pharmacy benefit managers (CVS Caremark, Express Scripts e Optum Rx) processaram cerca de 80% dos pedidos de receita equivalentes em 2025 [18]. Os preços são negociados ao abrigo do IRA [1, p. 33] e seguem uma política de quatro patamares baseada no rendimento nacional [1, p. 41]. Os produtos são prescritos por médicos, que não os pagam [1, p. 32]. A pressão sobre os preços é um Risco Principal [1, p. 48].	FORTE
Produtos substitutos	*Custo:* quando a exclusividade termina, os genéricos entram a preços mais baixos. As vendas da Brilinta caíram 38% para $823m após a entrada de genéricos nos EUA e na Europa [1, pp. 18, 56], e a Symbicort erodiu na UE e no Japão [1, p. 20]. A Farxiga ainda cresceu 10% em 2025 apesar da concorrência de genéricos em alguns mercados [1, p. 56]. A IQVIA estima mais de $90bn em vendas que vão perder exclusividade em 2025–2029 [19]. Os genéricos são aqui tratados como produtos substitutos, porque substituem o produto de marca pelo mesmo princípio ativo a um preço mais baixo [13, p. 24].	FORTE ao longo do tempo, por produto

ANÁLISE

Para quem já está dentro, o setor é atrativo: é muito difícil entrar. Mas cada produto só rende bem durante um tempo limitado. Enquanto um medicamento está protegido, os pagadores têm a vantagem; depois de a patente expirar, os genéricos tomam conta. Por isso, o verdadeiro jogo é renovar continuamente o portefólio. Duas classificações dependem de onde se traça a fronteira: se os genéricos fossem contados como novos concorrentes, essa força seria mais forte, e a baixa ameaça de entrada só se mantém enquanto as patentes continuarem protegidas [1, p. 49].

3.3.3 Dentro da empresa: a cadeia de valor

A cadeia de valor divide o que a AstraZeneca faz em atividades principais, que produzem e entregam os medicamentos, e atividades de suporte, que tornam o resto possível. O material da unidade curricular

liga ainda estas atividades à estrutura de custos e ao lucro [13, p. 25], e pergunta o que a empresa faz bem e menos bem, incluindo as suas pessoas e a sua cultura [13, p. 26].

Tabela 3.5. Para onde vai cada dólar de receita em 2025, em % da Receita Total, calculado a partir da demonstração de resultados [1, p. 125]. A margem bruta é de 81.9%.

Rubrica	% da receita
Comerciais e administrativos	33.9
I&D	24.2
Custo das vendas	18.1
Distribuição	1.0
Margem operacional	**23.4**

Atividade	Evidência	Pontos fracos	Avaliação

Tabela 3.6. Análise da cadeia de valor. As classificações não são dadas no Relatório e Contas.

Atividade	Evidência	Pontos fracos	Avaliação
Atividades principais			
Logística de entrada	A maior parte do fabrico de API é externa, complementada por capacidade interna crescente, e um programa de financiamento da cadeia de fornecimento apoia os fornecedores externos [1, p. 33].	A falta de medicamentos atingiu níveis recorde em 2025 [1, p. 33]; não conseguir manter o fornecimento é um Risco Principal [1, p. 48].	NEUTRO / RISCO
Operações	31 instalações de operações em 15 países (excluindo as de fornecimento clínico) e desempenho de fornecimento superior a 99% [1, pp. 4, 33]. 63 inspeções GMP e GDP de autoridades de saúde com zero achados críticos [1, p. 31]. A revisão do CEO cita zero recolhas ao nível do doente e zero observações críticas em 42 inspeções externas [1, p. 4].	10 recolhas de produto [1, p. 31]. O AR não reconcilia as contagens de 42 e de 63 inspeções.	FORÇA
Logística de saída	A despesa de distribuição foi de $579m, 1.0% da receita (calculado) [1, p. 125]. São reportados 217 lançamentos no mercado dentro do prazo em Operações [1, pp. 27, 33].	O AR não dá dados de desempenho de entrega.	NEUTRO
Marketing e vendas	47,400 colaboradores na área comercial [1, p. 27]; 16 medicamentos acima de $1bn [1, p. 4]; vendas através de empresas de marketing detidas integralmente, distribuidores e escritórios locais [1, p. 32].	Cinco produtos são 51% da receita (calculado: $30,045m ÷ $58,739m) e a Farxiga sozinha é 14.5% [1, p. 56]. Os EUA são 43% da receita, com pressão sobre os preços [1, pp. 2, 32].	FORÇA risco de concentração
Serviços pós-venda	Farmacovigilância ao longo de todo o ciclo de vida do produto [1, p. 31]; programas de apoio ao doente [1, p. 41]; mais de 200 parcerias com sistemas de saúde em 50 países [1, p. 4].	10 recolhas de produto [1, p. 31].	FORÇA
Atividades de suporte			
I&D e tecnologia	Despesa de I&D de $14,232m, 24.2% da receita (calculado) [1, pp. 28, 125]; 197 projetos em pipeline [1, p. 30]; mais de 90% da descoberta de moléculas pequenas com apoio de IA [1, p. 36].	20 projetos descontinuados em 2025, 11 por segurança ou eficácia [1, p. 30]; o ensaio de Fase III da Fasenra na DPOC não atingiu o objetivo primário [1, p. 20].	FORÇA

Atividade	Evidência	Pontos fracos	Avaliação
Recursos humanos e cultura	86% dizem que a AstraZeneca é um ótimo lugar para trabalhar (inquérito Pulse) [1, pp. 5, 38]; 89% reportam formação ou desenvolvimento [1, p. 39]; mais de 50,000 colaboradores participaram no programa de IA [1, pp. 5, 39]. Os cinco valores do Grupo estão em [1, p. 8].	4,441 incumprimentos do Código de Ética registados e 434 pessoas afastadas das suas funções [1, p. 34]. A rotatividade não é divulgada.	FORÇA
Gestão financeira	Fluxo de caixa operacional de $14,575m (+23%) [1, p. 10]. Prioridades de capital: investir no negócio e no pipeline, manter um rating de grau de investimento, prosseguir o desenvolvimento de negócio e pagar um dividendo progressivo [1, p. 10].	Dívida líquida de $23,374m, 1.6 vezes o fluxo de caixa operacional (calculado) [1, p. 61].	FORÇA alavancagem a monitorizar
Recursos físicos	Uma fábrica de $4.5bn na Virgínia e uma expansão de $2bn em Maryland [1, pp. 4, 33]. As emissões de Âmbito 1 e 2 estão 88.1% abaixo de 2015 [1, p. 42].	Face a uma meta de −98% até 2026 [1, p. 42]. A fábrica de comprimidos de Bangalore fechou em maio de 2025 [1, p. 33].	FORÇA
Aprovisionamento	Dupla fonte de fornecimento, múltiplos fornecedores e monitorização de stocks [1, p. 48].	O AR descreve a mitigação, não o desempenho.	NEUTRO
Administração e risco	Cada função do SET avalia o risco trimestralmente, alimentando o Group Risk Report para o Conselho de Administração, a Comissão de Auditoria e o SET [1, p. 47]. O programa de reestruturação PAAGR gerou benefícios anuais recorrentes antes de impostos de $1.9bn [1, p. 59].	Todas as decisões operacionais significativas são tomadas ao nível do SET [1, p. 147]	NEUTRO / RISCO
Margem			
Estrutura de custos e margem	2025, % da Receita Total (calculado a partir de [1, p. 125]): custo das vendas 18.1%, distribuição 1.0%, I&D 24.2%, custos comerciais, gerais e administrativos 33.9%. Margem bruta 81.9% e margem operacional 23.4%.	—	FORÇA

ANÁLISE

A maior parte da cadeia funciona bem: o fornecimento é fiável, a despesa em investigação é elevada e o negócio gera bastante liquidez. Os pontos fracos estão nas extremidades: as matérias-primas dependem de fornecedores externos, as vendas dependem de um punhado de produtos, e alguns projetos de investigação falham. O material da unidade curricular pede que se compare com os concorrentes [13, p. 24], mas a única comparação com pares no Relatório e Contas é o retorno para o acionista a dez anos: 307%, contra 197% dos pares farmacêuticos globais e 65% dos pares europeus [1, p. 90]. Para tudo o resto, o Grupo só pode ser comparado com o seu próprio histórico e com as suas metas.

3.3.4 Que recursos dão vantagem: VRIO

A VRIO faz quatro perguntas sobre cada recurso: cria valor, é raro no setor, é difícil ou dispendioso de imitar, e está a empresa organizada para o aproveitar? Só um recurso que passe as quatro conta como vantagem competitiva [13, p. 26]. Como o Relatório e Contas não compara a AstraZeneca com os seus rivais, as respostas abaixo são uma avaliação, não uma declaração da empresa.

Tabela 3.7. Análise VRIO: Valor, Raridade, Imitabilidade, Organização. O resultado segue a regra do material da unidade curricular [13, p. 26].

Recurso	Porquê	V	R	I	O	Resultado
Pipeline e I&D	197 projetos; 20 medicamentos novos em fases avançadas ou em avaliação; 43 aprovações relevantes em 2025 nos EUA, UE, China e Japão [1, pp. 28, 30]	S	S	S	S	VANTAGEM
Liderança em oncologia	$25.6bn (+15%) e cinco medicamentos acima de $1bn; as afirmações de liderança são do próprio Grupo [1, pp. 4, 12–14]	S	S	S	S	VANTAGEM
Patentes dos produtos atuais	A lei bloqueia as cópias enquanto duram; a Farxiga perde a exclusividade nos EUA em 2026 [1, pp. 9, 33]	S	S	S	S	ATÉ EXPIRAR
Excelência operacional	Desempenho de fornecimento >99% e 217 lançamentos dentro do prazo [1, pp. 4, 27]	S	S	N	S	PARIDADE pode ser copiada
Presença global	Vendas em mais de 125 países; os Mercados Emergentes são 26% da receita [1, pp. 2, 32–33]	S	N	N	S	PARIDADE os rivais também a têm
IA e dados	Mais de 90% da descoberta de moléculas pequenas usa IA; unidade Enterprise AI criada em dezembro de 2025; escalar a IA está listado como Risco Principal [1, pp. 36, 48]	S	N	N	S	PARIDADE comum ao setor
Rede de parcerias	Mais de 1,000 colaborações em todo o mundo [1, p. 37]	S	N	N	S	PARIDADE os rivais também a têm

ANÁLISE

A verdadeira vantagem da AstraZeneca é a sua **capacidade de inovar**: o pipeline, a I&D e a sua posição em oncologia. As patentes também a protegem, mas apenas até expirarem. As operações, o alcance global, a IA e as parcerias são valiosos, mas os concorrentes também os têm ou os podem construir, pelo que não distinguem a empresa. Isto coincide com o que Porter mostrou: o sucesso depende de renovar o portefólio.

3.3.5 Juntar tudo: a SWOT

A SWOT reúne os pontos mais importantes das quatro ferramentas. Da PESTEL, mantêm-se os fatores com impacto alto ou médio; das outras ferramentas, os pontos que mais pesam ou que aparecem mais do que uma vez. Sob cada ponto, um rótulo cinzento mostra de que ferramenta veio, para que a origem da informação esteja sempre visível. As forças cujo rótulo está marcado como paridade passaram o teste do valor mas falharam o teste da raridade ou o da imitabilidade da VRIO: são necessárias para competir, mas não distinguem a empresa.

Tabela 3.8. Matriz SWOT da AstraZeneca, com a ferramenta de origem de cada ponto.

Código	Fator	Evidência e origem
Forças — dentro da empresa, hoje		
S1	**Pipeline e I&D fortes**	$14.2bn investidos (24% da receita), 197 projetos, 20 medicamentos novos em fases avançadas [1, pp. 28, 30, 125] *VRIO · Pipeline* *Cadeia de valor · I&D*
S2	**Liderança em oncologia**	44% da receita, a crescer 15% [1, pp. 2, 4, 13] *VRIO · Oncologia*
S3	**Alcance global, portefólio amplo**	Vendas em mais de 125 países; 16 medicamentos acima de $1bn [1, pp. 4, 32] *VRIO · Presença global: paridade* *Cadeia de valor · Vendas*
S4	**Operações fiáveis**	Fornecimento >99%, 217 lançamentos dentro do prazo, zero achados críticos em 63 inspeções [1, pp. 4, 27, 31] *VRIO · Operações: paridade* *Cadeia de valor · Operações*
S5	**Capacidade financeira e margem**	Margem bruta de 81.9% e margem operacional de 23.4%; fluxo de caixa operacional de $14.6bn (+23%), contra dívida líquida de $23.4bn [1, pp. 10, 61, 125] *Cadeia de valor · Finanças*
S6	**Uso avançado de IA**	Mais de 90% da descoberta de moléculas pequenas usa IA; unidade de IA dedicada [1, pp. 5, 36] *VRIO · IA: paridade* *Cadeia de valor · I&D*
S7	**Capacidade comprovada de reestruturar**	O programa PAAGR gerou benefícios anuais recorrentes antes de impostos, antes de reinvestimento, de $1.9bn [1, p. 59] *Cadeia de valor · Administração*
Fraquezas — dentro da empresa, hoje		
W1	**Demasiada receita em cinco produtos**	Farxiga, Tagrisso, Imfinzi, Ultomiris e Calquence somam $30,045m: 51% da Receita Total, ou 54% das Vendas de Produtos em base comparável (calculado a partir de [1, pp. 56, 125]) *Cadeia de valor · Vendas*
W2	**Forte dependência dos EUA**	43% da receita, a caminho de cerca de 50% até 2030 [1, pp. 2, 4, 32] *Cadeia de valor · Vendas*
W3	**Produtos mais antigos já a perder terreno**	Brilinta −38% após os genéricos; Symbicort a erodir na UE e no Japão [1, pp. 18, 20, 56] *Porter · Produtos substitutos* *Cadeia de valor · Vendas*
W4	**Crescimento lento ou negativo em algumas áreas**	Cardiovascular, renal e metabolismo +3% ($12.8bn, 22% da receita); vacinas −13% [1, pp. 4, 17, 56] *Cadeia de valor · Vendas*
W5	**Atrasada na meta climática de 2026**	−88.1% de emissões face a uma meta de −98%; o clima não é um Risco Principal no AR [1, pp. 42, 47] *Cadeia de valor · Instalações*
W6	**Contratempos no pipeline**	20 projetos parados em 2025, 11 por segurança ou eficácia; a Fasenra falhou um ensaio de Fase III na DPOC [1, pp. 20, 30] *Cadeia de valor · I&D*

Código	Fator	Evidência e origem
W7	**Decisões operacionais concentradas no SET**	Todas as decisões operacionais significativas são tomadas ao nível do SET [1, p. 147], o que atrasa a resposta local de que a estratégia depende *Cadeia de valor · Administração*
Oportunidades — fora da empresa, futuro		
O1	**Procura crescente**	Envelhecimento e doença crónica [1, pp. 6–7] *PESTEL · Social*
O2	**Despesa em saúde a crescer**	+7.1% por ano até 2029; vendas farmacêuticas +10% em 2025 [1, p. 6] *PESTEL · Económico*
O3	**Mercados emergentes**	$15.3bn (+12%), +19% fora da China [1, pp. 4, 33] *PESTEL · Económico*
O4	**IA e novas tecnologias**	$4–7bn por ano para o setor; acesso através de mais de 1,000 colaborações [1, pp. 7, 37] *PESTEL · Tecnológico*
O5	**Grandes necessidades não satisfeitas**	Hipertensão, cancro e doenças raras, em que menos de 10% têm tratamento [1, pp. 13, 17, 23] *PESTEL · Social*
O6	**Acordo com os EUA que premeia a produção local**	Isenção tarifária de três anos, a par de preços alinhados com os de outros países ricos [1, pp. 4, 32–33] *PESTEL · Político*
O7	**O setor é difícil de entrar**	Desenvolver um medicamento custa milhares de milhões e leva 5 a 15 anos, para além da barreira regulamentar, pelo que a ameaça de novos concorrentes é fraca e o valor fica com quem já está dentro [16], [1, p. 9] *Porter · Novos concorrentes*
Ameaças — fora da empresa, futuro		
T1	**Pressão sobre os preços**	Orçamentos apertados, negociação IRA (Farxiga 2026, Calquence 2027), pagadores consolidados [1, pp. 7, 32–33], [18] *PESTEL · Económico, Legal* *Porter · Clientes*
T2	**Patentes a expirar**	A Farxiga (14.5% da receita) perde a exclusividade nos EUA em 2026; o AR espera que isto seja gerível. Mais de $90bn de vendas do setor em risco até 2029 [1, pp. 33, 56], [19] *Porter · Produtos substitutos* *VRIO · Patentes*
T3	**Geopolítica e tarifas**	Rivalidade EUA–China e controlos ao comércio [1, pp. 6, 49] *PESTEL · Político*
T4	**Rivalidade intensa**	Grandes rivais de dimensão semelhante [15], [1, p. 3] *Porter · Rivalidade*
T5	**Patentes mais fracas, novas regras da UE, atrasos nas aprovações**	[1, pp. 48, 49], [14] *PESTEL · Legal*
T6	**Rutura no fornecimento e no clima**	Falta de medicamentos em níveis recorde, API externos concentrados na Índia e na China, fenómenos climáticos extremos [1, pp. 7, 33, 44], [17] *Porter · Fornecedores* *PESTEL · Ambiental*

3.3.6 O que mais importa

Os 27 pontos não pesam todos o mesmo. São ordenados pelo seu peso na receita, pela rapidez com que se fazem sentir, pelo facto de o Relatório e Contas os tratar ou não como prioridade ou Risco Principal, e pela possibilidade de serem medidos.

Dentro da empresa

1. 51% da receita vem de cinco produtos, 14.5% só da Farxiga; o outro lado do forte portefólio de

oncologia [1, pp. 2, 56]

2. 9 dos 20 medicamentos novos prometidos para 2030 já foram entregues, sustentados por $14.2bn de I&D. O AR considera o sucesso da I&D crucial [1, pp. 10, 28, 52]
3. $14.6bn de fluxo de caixa operacional e um fornecimento >99% financiam e executam o plano de $50bn nos EUA, contra $23.4bn de dívida líquida [1, pp. 4, 10, 61]

Fora da empresa

1. Em 2026 a Farxiga perde a exclusividade nos EUA e recebe um preço negociado no mesmo ano; a Calquence segue-se em 2027 [1, pp. 33, 56]
2. Passar de 43% → 50% da receita nos EUA até 2030 é a exposição da própria empresa (W2); o que está fora é a política que atua sobre ela — preços negociados pelo Medicare e pagadores concentrados em três pharmacy benefit managers que tratam cerca de 80% das receitas médicas dos EUA [1, pp. 2, 4, 32], [18]
3. +7.1% por ano na despesa em saúde e uma carga de doença crescente: o contrapeso às duas ameaças acima [1, pp. 6, 7, 13, 17]

ANÁLISE

A ligação entre os dois

Tudo se resume a uma corrida: lançar medicamentos novos mais depressa do que os antigos perdem proteção. A Brilinta já perdeu 38% das suas vendas e a Farxiga, o maior produto, está prestes a perder a exclusividade nos EUA [1, pp. 33, 56]. O mercado continua a crescer em valor, mas cada produto rende durante menos tempo e a um preço mais baixo.

3.3.7 Cruzamento dos fatores

O material da unidade curricular sugere quatro perguntas para ligar o interior ao exterior [13, pp. 27–28]. Cada célula responde a uma delas.

Tabela 3.9. Os quatro cruzamentos entre o interior e o exterior. As células não são dadas no Relatório e Contas.

	Cruzamento	O que significa para a AstraZeneca
Forças	**Crescer** (SO)	Usar o pipeline e a oncologia (S1, S2) para responder à procura crescente, à despesa em saúde a subir e às necessidades não satisfeitas (O1, O2, O5), e a IA (S6) para acelerar a investigação (O4). As barreiras à entrada mantêm esses ganhos com as empresas que já estão dentro (O7).
	Defender (ST)	Usar o alcance global (S3) contra as tarifas e a geopolítica (T3), renovar o portefólio (S1) antes de as patentes expirarem (T2), e usar a liquidez e a capacidade comprovada de reestruturar (S5, S7) para financiar fábricas nos EUA e aquisições contra as tarifas (T3).
Fraquezas	**Corrigir** (WO)	Reduzir a dependência de cinco produtos (W1) entrando em áreas de grande necessidade como a hipertensão (O5), onde o baxdrostat tem dois resultados positivos de Fase III [1, p. 17]. Os mercados emergentes (O3) acrescentam crescimento, mas com os mesmos produtos de topo [1, p. 56].
	Evitar (WT)	A concentração e os produtos em declínio (W1, W3) combinados com a pressão sobre os preços e as patentes a expirar (T1, T2) são a mistura mais perigosa, e o mesmo vale para a dependência dos EUA (W2) sob pressão de preços e de política (T1, T3). As decisões concentradas no SET (W7) atrasam a resposta local que a pressão sobre os preços (T1) exige.

3.3.8 Estratégia proposta

O material da unidade curricular pede que se ponderem várias alternativas antes de escolher uma [13, pp. 3, 7, 29]. Não oferece uma lista de estratégias genéricas, e o Relatório e Contas não rejeita nenhuma opção, pelo que se comparam abaixo as três alavancas que o próprio relatório descreve.

Tabela 3.10. Alternativas consideradas antes de escolher a estratégia.

Papel	Alavanca	Evidência e a que responde
Núcleo	Crescimento orgânico através da I&D	Medicamentos novos e novas utilizações dos existentes; 12 primeiras aprovações de ciclo de vida em 2025 [1, pp. 4, 52]. Responde a S1, S2 → O1, O5, O7, T2.
Complemento	Aquisições, licenças e parcerias	Por exemplo a EsoBiotec, até $1bn [1, pp. 37, 48]. Responde a T2, W1, W3.
Mantido como política	Remunerar os acionistas	Dividendo progressivo de $3.20 por ação [1, pp. 3, 10]. Importante, mas não corrige nenhuma fraqueza nem ameaça.

A estratégia proposta é o **crescimento através da inovação, com renovação mais rápida do portefólio, melhor equilíbrio geográfico e fornecimento seguro**. Baseia-se nos quatro cruzamentos, em cinco ações. O crescimento em si assenta em S1 e S2, os dois recursos que a VRIO confirma como vantagens que não expiram; S3, S4 e S6 são condições para executar a estratégia, não fontes de vantagem em si mesmas.

1. **Focar a I&D onde a empresa lidera ou quer liderar** Oncologia, cardiovascular, renal e metabolismo, respiratória e imunologia, e doenças raras, usando IA para reduzir o tempo de desenvolvimento. Medicamentos em fase avançada como o baxdrostat respondem também ao crescimento lento na área cardiovascular [1, p. 17]. *S1, S2, S6 → O1, O4, O5 · W4*

2. **Substituir a receita que as patentes vão retirar** Com medicamentos novos e novas indicações, complementados com aquisições, licenças e parcerias [1, pp. 37, 48]. *S1, S5 → T2, W1, W3*

3. **Crescer nos mercados emergentes e produzir localmente onde compensa** Os mercados emergentes trazem $15.3bn e crescem 12% [1, pp. 4, 33]; fábricas locais nos EUA, na China e em Singapura [1, pp. 4, 5, 32, 37]. Isto contraria a subida do peso dos EUA para cerca de 50% até 2030 [1, p. 4]. *S3 → O3, O6, T3*

4. **Mostrar aos pagadores quanto valem os medicamentos e deixar as regiões adaptar-se** Manter a política de preços em quatro patamares e os acordos baseados em resultados [1, pp. 41, 48], mas dar às equipas comerciais regionais margem para adaptar o acesso e o preço dentro de limites definidos centralmente. Hoje, todas as decisões operacionais significativas são tomadas ao nível do SET [1, p. 147]; delegar esta aproxima a decisão do pagador que é preciso convencer, e o PAAGR mostra que o Grupo consegue reorganizar-se a essa escala [1, p. 59]. *S7 → T1 · W7*

5. **Garantir o fornecimento e cumprir o plano climático** Manter o fornecimento acima de 99% [1, p. 4], acrescentar capacidade [1, p. 33] e fechar a distância para a meta de −98% de emissões [1, p. 42]. *S4 → T6, W5*

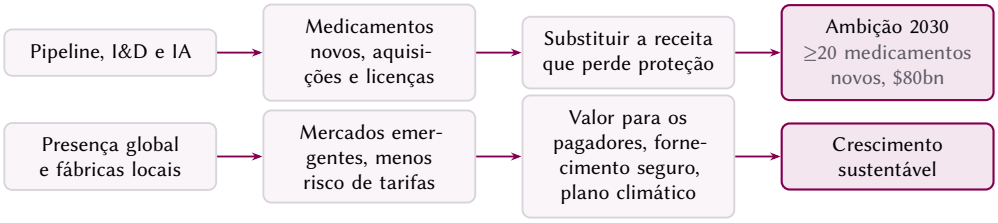


Figura 3.2. Como as cinco ações conduzem à Ambição 2030. As metas de 2030 são do Grupo [1, p. 10].

Duas fraquezas ficam sem ação dedicada: a dependência dos EUA (W2) e os contratempos no pipeline (W6), que são aqui tratados como riscos a vigiar. A rivalidade e as regras das patentes (T4, T5) estão fora do controlo da empresa, e a estratégia responde-lhes indiretamente ao renovar o portefólio.

Como se compara isto com o que a AstraZeneca já diz? A sua estratégia declarada, *Growth Through Innovation*, tem três prioridades [1, pp. 2, 10, 11], e o Relatório e Contas enumera mitigações semelhantes para os seus principais riscos [1, p. 48]. As ações 1, 2 e 5 mantêm-se próximas dessa estratégia. As ações 3 e 4 afastam-se dela: a Ação 3 dá mais peso aos mercados emergentes do que a empresa dá, e a Ação 4 propõe delegar decisões de preço que hoje são tomadas centralmente. O que isto acrescenta é o caminho explícito da SWOT para os cruzamentos e destes para a ação, e a escolha entre alavancas.

Tabela 3.11. Indicadores para acompanhar a estratégia. As metas são declaradas pelo Grupo; a escolha dos indicadores não é. O Relatório e Contas não fixa nenhuma meta para a concentração da receita nem para as áreas de crescimento lento. A medida de fluxo de caixa do scorecard é o fluxo de caixa operacional menos o investimento em ativos fixos, mais as receitas de alienações de ativos intangíveis [1, p. 91], razão pela qual é mais baixa do que os $14.6bn em S5.

Objetivo	Indicador	Hoje	Meta declarada
Renovar o portefólio	Medicamentos novos aprovados desde out. de 2022	9	≥ 20 até 2030 [1, p. 10]
Crescer	Receita Total	$58.7bn (2025)	$80bn até 2030 [1, p. 10]
Produtividade da I&D	Eventos regulamentares por ano	97 (2025)	Meta de 2025 de 54, com 69 contabilizados; 2026 não divulgado [1, pp. 91, 102]
Produtividade da I&D	Eventos de progressão do pipeline	38 (2025)	Meta de 2025 de 29, com 36 contabilizados [1, pp. 11, 91]
Capacidade financeira	Fluxo de caixa (medida do scorecard do Grupo)	$11.9bn (2025)	Meta de 2025 de $11.3bn [1, p. 91]
Sustentabilidade	Emissões de Âmbito 1 e 2 face a 2015	−88.1%	−98% até 2026 [1, p. 42]
Sustentabilidade	Emissões de Âmbito 3 face a 2019	—	−50% até 2030, −90% até 2045; zero emissões líquidas até 2045 [1, p. 42]

Referências

[1] AstraZeneca PLC, "Annual Report and Form 20-F Information 2025," AstraZeneca PLC, Cambridge, U.K., Tech. Rep., 2026, [Online]. Available: https://www.astrazeneca.com/investor-relations/annual-reports/annual-report-2025.html. [Accessed: Sep. 19, 2026].

[2] ——, “Form 20-F for the fiscal year ended December 31, 2025,” U.S. Securities and Exchange Commission, Washington, DC, USA, Tech. Rep., 2026, [Online]. Available: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/901832/000110465926019130/azn-20251231x20f.htm. [Accessed: Sep. 19, 2026].

[3] Instituto Superior de Engenharia do Porto, “Introdução à gestão,” Class notes, Gestão, Licenciatura em Engenharia Informática, Porto, Portugal, Feb. 2024.

[4] AstraZeneca PLC, “Nature,” astrazeneca.com, [Online]. Available: https://www.astrazeneca.com/sustainability/nature.html. [Accessed: Sep. 19, 2026].

[5] ——, “AZ Forest,” astrazeneca.com, [Online]. Available: https://www.astrazeneca.com/sustainability/climate-change/az-forest.html. [Accessed: Sep. 19, 2026].

[6] ——, “Leadership,” astrazeneca.com, [Online]. Available: https://www.astrazeneca.com/our-company/leadership.html. [Accessed: Oct. 10, 2026].

[7] ——, “Results of Annual General Meeting held on 9 April 2026,” astrazeneca.com, Apr. 2026, apr. 9, 2026. [Online]. Available: https://www.astrazeneca.com/content/dam/az/PDF/2026/Results-of-Annual-General-Meeting-held-on-9-April-2026.pdf. [Accessed: Oct. 15, 2026].

[8] ——, “Directorate change: Non-Executive Board Appointment,” news.cision.com, Sep. 2026, sep. 1, 2026. [Online]. Available: https://news.cision.com/astrazeneca/r/directorate-change,c4390185. [Accessed: Oct. 15, 2026].

[9] Instituto Superior de Engenharia do Porto, “Função organização,” Class notes, Gestão, Licenciatura em Engenharia Informática, Porto, Portugal, Sep. 2024.

[10] AstraZeneca PLC, “About us,” careers.astrazeneca.com, [Online]. Available: https://careers.astrazeneca.com/about-us. [Accessed: Oct. 15, 2026].

[11] ——, “AstraZeneca appoints Aradhana Sarin as new Chief Financial Officer,” astrazeneca.com, 2021, [Online]. Available: https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/astrazeneca-appoints-aradhana-sarin-as-new-chief-financial-officer.html. [Accessed: Oct. 15, 2026].

[12] ——, “AstraZeneca appoints Sharon Barr as Executive Vice President BioPharmaceuticals R&D,” astrazeneca.com, 2023, [Online]. Available: https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2023/astrazeneca-appoints-sharon-barr-as-executive-vice-president-biopharmaceuticals-rd.html. [Accessed: Oct. 15, 2026].

[13] Instituto Superior de Engenharia do Porto, “Função planeamento,” Class notes, Gestão, Licenciatura em Engenharia Informática, Porto, Portugal, Sep. 2026.

[14] Council of the European Union, “Pharma package: Council and Parliament reach a deal on new rules for a fairer and more competitive EU pharmaceutical sector,” Press release, Dec. 2025, updated Mar. 6, 2026. [Online]. Available: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/12/11/pharma-package-council-and-parliament-reach-a-deal-on-new-rules-for-a-fairer-and-more-competitive-eu-pharmaceutical-sector/. [Accessed: Oct. 10, 2026].

[15] Drug Discovery & Development, “Pharma 50: The 50 largest pharmaceutical companies in the world for 2025,” drugdiscoverytrends.com, 2025, [Online]. Available: https://www.drugdiscoverytrends.com/pharma-50-the-50-largest-pharmaceutical-companies-in-the-world-for-2025/. [Accessed: Oct. 10, 2026].

[16] A. Mullard, “New drugs cost US$2.6 billion to develop,” *Nature Reviews Drug Discovery*, vol. 13, no. 12, p. 877, Dec. 2014.

[17] E. Duman, “Global active pharmaceutical ingredient manufacturing capacity remains concentrated despite shifting production trends,” Quality Matters, U.S. Pharmacopeia, Jun. 2026, [Online]. Available: https://www.usp.org/blog/global-active-pharmaceutical-ingredient-manufacturing-capacity-remains-concentrated-despite. [Accessed: Oct. 10, 2026].

[18] A. J. Fein, “The top pharmacy benefit managers of 2025: Market share and key industry developments,” Drug Channels, Mar. 2026, [Online]. Available: https://www.drugchannels.net/2026/03/the-top-pharmacy-benefit-managers-of.html. [Accessed: Oct. 10, 2026].

[19] S. Lauks, C. Ge, D. Luft, R. Perak, L. Greenwalt, and J. Cattell, “The rules of loss of exclusivity are being rewritten,” IQVIA, Jul. 2025, [Online]. Available: https://www.iqvia.com/locations/united-states/blogs/2025/07/the-rules-of-loss-of-exclusivity-are-being-rewritten. [Accessed: Oct. 10, 2026].